

基于“肺开窍于鼻”探讨寒鼽*

李林美, 谷 峰[△]

(辽宁中医药大学, 辽宁 沈阳 110847)

摘要: 鼻为呼吸之门户,与肺相连,是肺与外界相通的重要通道,同时也是外邪侵袭肺脏的主要途径。《素问·金匱真言论》言“开窍于鼻,藏精于肺”,鼻部的症状与肺休戚相关。而鼻鼽是以鼻部症状为主的疾病,其发病与肺的功能失调密不可分。且寒邪在其发病中占有重要地位,寒性鼻鼽在临床上极其常见,所以对寒性鼻鼽的系统剖析格外重要。基于“肺开窍于鼻”理论阐释了鼻鼽因寒伤肺而发于鼻的发病机理,并对寒性鼻鼽进行了主症辨析,探讨其各主症的演变机制,以及本病的临床治疗。寒为阴邪,专伤阳气,寒邪致鼽主要是由寒伤卫阳破坏人体防御机制、阳虚生饮上犯鼻窍与脾、肾阳失煦而肺寒不温三方面形成。

关键词: 鼻鼽; 过敏性鼻炎; 变应性鼻炎; 寒邪; 黄帝内经

中图分类号: R765. 21

文献标志码: A

文章编号: 1007-2349(2025)03-0021-04

DOI:10.16254/j.cnki.53-1120/r.2025.03.001

“鼻鼽”即现代医学的变应性鼻炎^[1],又称过敏性鼻炎,是人体在接触变应原后主要由免疫球蛋白 E 介导的组胺炎症介质释放导致,以鼻痒、阵发性喷嚏、流清水样涕、鼻塞、嗅觉障碍等为主症的疾病,具有发作突然、迁延难愈、病情易反复的特点^[2]。鼻鼽的发病率逐年升高,且患者群体已呈现明显低龄化,这与我们的自然环境、生活习惯及社会环境的变化密切相关^[3]。在西医治疗中,通常使用糖皮质激素、抗组胺药物、脱敏疗法以及外科治疗等方式,这些方法虽然在一定程度上能够起到治疗作用,但往往会伴随着不良反应,并且疗效难以确保,容易出现复发情况^[4]。然而中医药可治疗变应性鼻炎的各个阶段,对患者进行辨证施治,治病求本,不仅临床疗效显著,且安全性较高、毒副作用较少^[5]。

经文献学研究调查^[6]，“鼻鼽”的记载源于西周《礼记·月令》：“季秋行夏令，则其国大水，冬藏殃败，民多鼽嚏”，正式命名于《素问·脉解》：“阳明并于上，上者则孙络太阴也，故头痛、鼻鼽、腹肿也”，其理论发展贯穿整个中医史。本病的病因分为外因与内因，外因即风寒、火热之邪等，内因则主要与肺、脾、肾三脏的功能失调有关。肺虚卫外不固，脾虚土不生金，肾虚金水不生，故而发为鼻鼽^[7]。肺开窍于鼻，鼻部症状与肺的病变息息相关。中医理论认为五脏是一个整体，其在生理上有着千丝万缕的联系，在病理

方面也相互影响，鼻鼽的内因虽责于肺、脾、肾三脏，但可归结于脾、肾病变最终影响了肺的正常生理功能而表现出鼻部的异常症状。

1 “肺开窍于鼻”理论

“肺开窍于鼻”理论源于《黄帝内经》，其中关于鼻与肺的官窍与脏腑之络属关系的阐述颇为详尽，《素问·阴阳应象大论》言“肺主鼻……在窍为鼻”，又有《灵枢·五阅五使》云“鼻者，肺之官也”，为后世“肺鼻理论”的形成奠定了基础^[8]。肺主气司呼吸，鼻为呼吸之道，是肺与外界相通的孔窍，又因肺的经脉与鼻相连，故而形成“肺开窍于鼻”理论。

《灵枢·本脏》言“视其外应，以知其内脏，则知所病矣”，所以通观察人体外部形态上的表现，可以获取内在脏器的状况信息，以便了解脏器是否存在病变。肺窍开于鼻，故通过对鼻部的征象进行观察，从而测知肺脏的情况，反之，当肺病变时，鼻部亦会出现异常征象，正如《灵枢·本神》载“肺气虚则鼻塞不利”。肺与鼻的联系紧密，发病时症状往往相兼出现。

2 寒为鼻鼽的主要病因

鼻鼽的发病可由寒邪而致，且基于临床数据的挖掘统计发现^[9]，该病多因外感寒邪而发，中药治疗也以温性药物为主。《杂病源流犀烛·鼻病源流》载：“鼻鼽者，鼻流清涕不止，出肺经受寒而成也”；又如《辨证录·卷三》：“人有鼻流清涕，经年不愈，是肺气

* 基金项目: 国家中医药管理局第四批优秀人才研修项目(10010244B10038)

第一作者简介: 李林美(1998-),女,硕士研究生,研究方向: 中医基础理论(内经)。

[△]通信作者: 谷峰, E-mail: 46724238@qq.com

虚寒,非脑漏也”等,诸多论述皆表明寒邪是鼻鼽发病的常见病因。鼻鼽的病性多为“本虚标实”或“虚实错杂”,外寒侵袭肺脏时,肺主皮毛,肺虚则腠理疏松,难御外邪,内寒与外邪相合而发为鼻鼽;且根据“五脏一体观”,若脾、肾阳气不足,不仅会引起本脏的生理功能失调,还会对肺阳产生影响,从而影响到肺的生理功能^[1],最终导致鼻鼽。

2.1 寒伤肺卫 难御外邪 《素问·生气通天论》言:“阳者,卫外而为固也”。通常情况下,疾病的转归演变主要取决于人体的正气是否充足,而这种防卫功能主要取决于阳气的盛衰^[1]。又言“阳气者,若天与日,失其所,则折寿而不彰”,阳气对人体的重要性毋庸赘述,阳气的推动和气化作用与机体功能的正常运行密切相关^[2],而卫气是阳气的一部分,又称之为卫阳。

根据“卫出三焦”理论:先天卫气根源于下焦,原始卫气从肾阳而出,在中焦经脾胃运化得水谷精微充养,而后经上焦肺之宣发而布散于全身各处^[3-14],由此可见,肺、脾、肾的作用是卫气生成、输布的关键环节,卫气生成之后需要依赖肺的宣发肃降功能输送至全身各处。

寒为阴邪,最易伤阳,且肺为娇脏主表,外寒侵袭时从皮毛、口鼻而入,首先犯肺。寒邪袭肺时不仅直接引起肺失宣肃,导致肺气失利而清窍不通,出现鼻塞、流涕等症状;并且寒主收引,寒邪外侵可致使经络不通而引发鼻塞,如《景岳全书·鼻证》中曰“凡由风寒而鼻塞者,以寒闭腠理,则经络壅塞而多鼽嚏”的论述;同时寒伤肺阳致使卫气布散不利,防御力降低,无法抵御外邪而易感或加重鼻鼽。若寒邪直中脾、肾,便会直接影响卫阳的生成,影响防御功能而致鼽。

2.2 阳虚化饮 水湿聚肺 “饮入于胃,游溢精气,上输于脾,脾气散精,上归于肺,通调水道,下输膀胱,水精四布,五经并行”(《素问·经脉别论》),肺、脾、肾三脏与津液运行密切相关。《景岳全书·杂证谟》云“寒气在脏者,以阳气虚也”,若肺、脾、肾三脏阳气不足,则水液运化失司,饮邪内生,水饮留伏于肺,而出现一系列鼻部症状,是鼻鼽的重要内因^[15]。

脾胃为后天之本,气血生化之源,主运化,《难经·四十九难》曰“形寒饮冷则伤肺”,《灵枢·百病始生》中言“重寒伤肺”,外感寒邪与寒冷饮食均能伤肺,而寒冷食物入胃,直接损伤脾胃阳气而运化失

司,不能有效发挥吸收、传输水液的功能,致使水饮内留,停于中焦。《灵枢·经脉》曰“肺手太阴之脉,起于中焦”,水饮之邪还可循经上犯于肺,影响肺的生理功能。并且脾阳虚日久,还可对肺阳造成影响,肺阳不足,便难以将津液化开,导致津液停滞在肺部形成痰饮之邪而致鼽。而且饮为阴邪,易伤阳气,水饮之邪停于肺则肺阳更耗^[16],形成不良循环。

2.3 肾阳失煦 肺寒不温 肾为先天之本,肾阳为诸阳之本,各脏腑阳气均是以肾阳为基础的。肺属金,肾属水,金水相生,当肾阳充沛时,能够沿着经脉向上温暖肺脏,这样可以帮助肺部阳气充足,从而保障肺脏正常发挥生理功能。若肾阳虚衰,温煦失司,不能蒸腾气化水液,或是不能温煦肺阳影响津液布散,亦或不能温煦脾阳,均会导致水饮停聚,停聚于鼻窍则会引起鼻塞流涕。

3 寒鼽主症辨析

以下是就寒邪引发的鼻鼽的症状进行分析,包括鼻痒、喷嚏、流清涕、鼻塞和嗅觉障碍的主要症状机理。

3.1 鼻痒 风为百病之长,常与他邪相协侵袭人体,与寒邪相合最为常见。《灵枢·刺节真邪篇》言“虚邪之中人也……寒则真气去,去则虚,虚则寒搏于皮肤之间。其气外发,腠理开,毫毛摇,气往来行,则为痒”,可见风寒之邪搏结于鼻腔粘膜是鼻痒的主要原因。风为贼邪,逢虚则入,鼻窍为九窍之一,是人体与外界的沟通之道为虚处,易受外邪侵袭,并且鼻为阳窍,风为阳邪先袭阳位,故更易受风寒邪气侵袭。

3.2 喷嚏 喷嚏的发生机制有三:一是“嚏,鼻中因痒而气喷作于声也”(《素问玄机原病式·六气为病》),因风寒之邪搏结于鼻粘膜导致鼻痒而喷嚏;二是由于卫表不固,寒邪乘虚而入,上犯鼻窍,并束于皮毛之间,所以阳气无处发散,则上冲鼻窍,喷而为嚏^[17];三是由于肾阳虚,《素问·宣明五气论》有言:“肾为欠,为嚏”;《素问经注节解·卷之二》中注:肾乃寒水,气易冰凝,肾为肺子,上达于母,则发而为嚏,不独外寒风寒为嚏也”。肾阳虚则固摄封藏纳气的功能失常,这时气逆于上可见喷嚏频作^[18]。

3.3 流清水样涕 《素问玄机原病式·六气为病》言“鼽者,鼻出清涕也”,可见流清水样涕是鼻鼽的主要临床表现之一。“诸病水液,澄澈清冷,皆属于寒”(《素问·至真要大论》),寒盛则水液清晰,因此

流清水样涕主要是由外寒侵肺或肾阳虚不能固摄津液所致。《医法圆通·卷一》中对此进行了详细的论述“从外感而致者,感受外来之客邪,客于肺经,闭其清道,肺气不得下降,清涕是出……从内伤而得者,由心肺之阳不足,不能统摄津液……肾络通于肺,肾阳衰而阴寒内生,不能收束津液,而清涕亦出”。

3.4 鼻塞 《诸病源候论·鼻塞塞气息不通候》载:“肺气通于鼻。其脏为风冷所伤,故鼻气不宣利,壅塞成”,鼻塞多由风寒之邪所致,若风寒袭肺,寒主收引,极易导致气血津液流通不畅,津液停聚,则壅滞不畅,故鼻窍不通而鼻塞。亦有《素问·生气通天论篇》载“阳不胜其阴,则五脏气争,九窍不通”,其指出阳气不足时,阴寒内生,水饮停滞并聚集,上而侵袭鼻窍,从而导致鼻窍不通^[13]。

3.5 嗅觉障碍 《灵枢·脉度》曰“肺气通于鼻,肺和则鼻能知香臭矣”,指出嗅觉的灵敏程度,与肺气通利与否有关。肺气调和,肺气宣发肃降功能正常,鼻窍才能同通利,发挥其正常的嗅觉功能,若受寒邪侵袭,致使肺失宣肃,则会出现嗅觉减退的症状。《灵枢·邪气脏腑病形》有言“其血气皆上于面而走空窍……其宗气上出于鼻而为嗅”,人的十二经脉和三百六十五络脉的气血精微物质,全都上注于头面部,而入于各个孔窍之中,上出于鼻,使鼻能有嗅觉。脾为后天之本,气血生化之源,具有运化水谷精微的重要作用,《素问·玉机真脏论》曰“脾为孤脏……其不及则令人九窍不通”,若脾阳不振,运化失司,水谷精微无法上输于肺,导致不能濡养鼻窍而出现嗅觉障碍。

4 治疗

根据上述发病机制,分别从寒伤卫阳、内寒化生水饮与肺失温煦三方面治疗,运用散寒外、温内阳的方法来增强人体抵御邪气的能力,从而预防鼻鼽的频繁发作^[14]。《素问·评热病论》言“邪之所凑,其气必虚”,正虚为本、外邪为标是鼻鼽的基本病机,临床上当以扶正祛邪为基本治疗原则^[15]。吴拥军教授等^[20]认为肺虚而卫表不固致使风寒易袭,肺失宣肃是鼻鼽的主要病机,常以辛夷散为基础方,随证加减,可有效改善鼻部及全身症状。袁臻等^[21]运用具有补益肺气、调和营卫、散寒散邪之功的桂枝加黄芪汤,治疗肺气虚外感寒证患者效果显著。张健萱^[22]等以“阳虚感寒,寒饮内停”为基本病机,提出“以饮论治”,采取益气温阳化饮的治疗方法,以益肺卫之气为

核心,既散外寒又温补脾肾之阳,全面改善肺、脾、肾虚损的状态,从而达到卫气充盛,身体强健的状态,不受邪扰^[23],选择小青龙汤、麻黄细辛附子汤合玉屏风散为治疗此类型鼻鼽的基本方。肖伊等^[24]在临床中,用温补肾阳合益气固表法治疗肾阳虚型变应性鼻炎患者 152 例,具有显著的治疗效果,并且对临床症状、舌苔、脉象等有改善作用。麻黄附子细辛汤合肾四味汤此两种方药合用,共奏益气温阳、摄涕止鼽之功效,邓秀娟等^[25]实验证明合方可能通过多靶点发挥作用,可明显减轻变应性鼻炎大鼠的症状和鼻黏膜组织病变。

5 讨论

根据流行病学调查显示,全球约有 10%~25% 的人口饱受该病困扰^[26],给患者的生活带来了许多不良影响,因此关于有效治疗鼻鼽的问题至关重要。肺为娇脏,外寒侵袭或是阳气虚弱都会对肺的功能造成影响,只有肺的功能正常才能有效的宣发卫气,固护肌表,进而保持防御功能正常运作,否则腠理疏松,卫表不固,当外寒侵袭肺卫时,肺不能正常的宣发肃降,又因为肺开窍于鼻,而出现鼻塞、流涕等鼻部症状,引发鼻鼽。《素问·刺法论》曰“正气存内,邪不可干”,中医学非常重视人体的正气,强调人体的正气在发病中的主导地位。只有正气充足,才能有效抵御外邪入侵,寒伤卫阳而削弱正气是导致鼻鼽发病的重要环节,因此对寒性鼻鼽的理论探讨和临床研究十分必要。此外,如果寒性鼻鼽长期未得到治愈而气机不畅,也可能转化为热性鼻鼽,因此在临床诊疗中应该进行仔细全面的辨证施治,万不可以偏概全。

参考文献:

- [1] 王虹雨,齐凤军,张阳普,等. 从中医“正气”理论探讨变应性鼻炎的治疗[J]. 亚太传统医药,2022,18(1):211-213.
- [2] 陈晓晴,潘红玲,许天兵. 中医治疗变应性鼻炎的临床研究近况[J]. 针灸临床杂志,2019,35(6):87-91.
- [3] 郑晓骏,陈旭青,蒋中秋. 中西医结合中西结合治疗过敏性鼻炎的临床研究进展[J]. 医学综述,2022,28(10):1983-1987.
- [4] 李月,王旭. 基于鼻玄府理论从风论治变应性鼻炎[J]. 广西中医药,2019,42(5):51-53.
- [5] 刘莉莉,刘大新,刘锦峰,等. 中医药临床优势病种探讨——变应性鼻炎[J]. 中国实验方剂学杂志,2023,29(2):203-211.

基于肝与大肠相通理论从肝论治功能性便秘^{*}袁裕评, 李帅军[△]

(湖南中医药大学第二附属医院, 湖南 长沙 410208)

摘要: 功能性便秘是临床常见病, 随着生活压力增大, 现研究表明与情志密切相关, 且肝主情志, 调畅气机, 本文以中医“肝与大肠相通”理论为切入点, 与西医“肝肠轴”理论相结合, 探讨从肝论治功能性便秘, 为功能性便秘的防治提供思路 and 参考。

关键词: 肝与大肠相通; 功能性便秘; 从肝论治

中图分类号: R256.35

文献标志码: A

文章编号: 1007-2349(2025)03-0024-05

便秘多以大便次数较少, 大便干结难下, 呈羊屎粒或粪质正常但排便障碍为主要临床表现, 通常发病

时间超过 6 个月以上, 则可确诊为慢性便秘^[1]。相关调查显示, 在我国慢性便秘的发病机率为 4% ~

^{*} 基金项目: 2022 年湖南中医药大学校院联合基金教学改革重点研究项目(2022-LHJG003)

第一作者简介: 袁裕评(1999-), 女, 硕士研究生, 研究方向: 中医药防治肛肠疾病。

[△] 通信作者: 李帅军, E-mail: 543832915@qq.com

[1] 陈旭青, 周龙云, 严道南, 等. 基于文献论鼻鼹之病机与治则 [J]. 中华中医药杂志, 2017, 32(4): 1491-1494.

[2] 李可. 苍辛温肺汤治疗儿童变应性鼻炎(肺气虚寒证)的临床观察 [J]. 哈尔滨: 黑龙江中医药大学, 2023.

[3] 刘妍彤, 吕晓东, 庞立健, 等. 从“肺开窍于鼻”论肺系疾病易感体质 [J]. 辽宁中医药大学学报, 2016, 18(8): 72-74.

[4] 张静, 李文静, 刘军. 基于数据挖掘探讨中医和法治疗过敏性鼻炎用药规律 [J]. 光明中医, 2023, 38(17): 3291-3295.

[5] 常兴, 刘金凤, 汪艳丽, 等. 从“五脏一体观”角度探析肺阳与其他脏腑阳气联系 [J]. 辽宁中医药大学学报, 2020, 22(12): 168-171.

[6] 刘华, 阮芳华, 袁卫玲. 从火热辨识鼻鼹 [J]. 中华中医药杂志, 2017, 32(6): 2386-2388.

[7] 刘媛. 《黄帝内经》中“阳气”“阴气”概念之探微 [J]. 中国中医基础医学杂志, 2017, 23(8): 1042-1043+1046.

[8] 帅垠琦, 年李想, 严晓, 等. 基于“卫出三焦”理论辨治感染后咳嗽 [J]. 四川中医, 2023, 41(8): 53-56.

[9] 陈玥, 刘成帅, 姜春云, 等. 论“卫出三焦”与脏腑的关系 [J]. 中国民间疗法, 2020, 28(14): 9-11.

[10] 颜水平, 庄翔莉, 艾斯, 等. 郑健从“风饮伏肺”论治儿童变应性鼻炎经验 [J]. 中医药通报, 2023, 22(9): 11-13.

[11] 丁琦, 袁卫玲, 刘华. 从寒论治过敏性鼻炎的理论探讨 [J]. 辽宁中医杂志, 2016, 43(5): 942-943.

[12] 沈露娜, 吴昆旻, 殷立平. 中医药治疗变应性鼻炎的研究进展 [J]. 中医临床研究, 2020, 12(28): 143-146.

[13] 熊轶敏, 贾明月, 肖锶瑶, 等. 从阳论治变应性鼻炎经验

[J]. 环球中医药, 2021, 14(9): 1663-1666.

[14] 贺晋芳, 秦欣欣, 苏惠萍. 苏惠萍教授治疗过敏性鼻炎经验总结 [J]. 亚太传统医药, 2020, 16(2): 74-76.

[15] 陆荣锦, 薛珊珊, 邱歆莹, 等. 辛夷散加减治疗肺虚感寒型过敏性鼻炎临床疗效观察 [J]. 中华中医药杂志, 2023, 38(8): 3993-3996.

[16] 袁臻, 樊兰英. 桂枝加黄芪汤加减治疗变应性鼻炎肺气虚外感寒证的临床观察 [J]. 中国民间疗法, 2022, 30(17): 65-68.

[17] 张健萱. 基于 NF- κ B 信号通路探讨小青龙汤、麻黄细辛附子汤合玉屏风散对变应性鼻炎大鼠 NF- κ Bp65, p-CREB 及 AQP5 表达的影响 [D]. 沈阳: 辽宁中医药大学, 2023.

[18] 何腾, 彭顺林. 益气温阳法治疗变应性鼻炎的理论探讨 [J]. 辽宁中医杂志, 2017, 44(7): 1405-1407.

[19] 肖伊, 刘真, 刘建华. 温补肾阳合益气固表法在变应性鼻炎治疗中的应用 [J]. 河北医学, 2016, 22(10): 1728-1731.

[20] 邓秀娟, 黄乐, 刘海燕, 等. 基于 TSLP-OX40L 通路探讨麻黄附子细辛汤合肾四味汤对变应性鼻炎大鼠的影响 [J]. 现代中西医结合杂志, 2023, 32(23): 3219-3224+3320.

[21] 张红丽, 赵铭辉, 胡焯涛, 等. “三伏天”穴位贴敷治疗变应性鼻炎疗效观察 [J]. 上海针灸杂志, 2017, 36(5): 588-593.

(收稿日期: 2024-06-28)